

Krankheit	Anamnese/Symptome	Status	Untersuchungen/ Abklärungen	Therapie	Kommentar
MUND					
Schmeckstörung	<u>Hypoguesie, Aguesie, Paraguesie, Phantoguesie</u> <u>Trigger:</u> Infekte, Hygiene, Alter, Psyche, Medis (Antimykotika), Mangelernährung, Neurologie, Chemo- und Radio-Tx etc.	Zunge + Mund inspizieren + palpieren , Sulcus amygdalogl., Motorik Zunge (Hypoglossus) Neurostatus: Trigemini testen (Sens., Sz., Kalt-Warm + Dermatome), Fazialis (Geschmack Ch. tympani + restl. Funktionen Fazialis), Glossopharyngeus (Geschmack)	Geschmack testen (Tast strips, + Geruch testen, Pat. verwechseln beides oft) Labor Ev. MRI/CT	Je nach Ursache: - Medi/Noxen-Stopp, Spontanerholung abwarten - Zink - meist keine Kausaltherapie	
Mukosa-Veränderungen (Mix)	Angina-Plaut-Vincenti: Spirochäten + Fusobakterien >Odynophagie >i.d.R. einseitig fibrinbedecktes Ulkus auf Tonsille >Gram-Präp >Mundflege + ev. Verätzung, AB (falls s. stark) Diphtherie: Corynebakt. Diphtheriae >Fieber, Schluck-Sz, LK >weissl. Beläge auf Tonsille/Uvula/Gaumensegel/Larynx, Azetongeruch >Abstrich + Kultur >Antiserum + Augmentin, Gurgeln Mononukleose/Pfeiff. Drüsenfieber: EBV > AZ red., Fieber, Kopf- + Glieder-Sz., Bauch-sz., kein Appetit, Schwellung Waldeyerring, LK, Systemerkrankung (Leber!) >Tonsillen hochrot + geschwollen, gelbl-grau-schleimige konflu. Beläge/Strassen>BE (atyp. LZ, mononukl. Zellen, Leberwerte, Serologie erst im Verlauf >IgM), US (Leber + Milz), EKG >sympt. NSAID (kein Aspirin), Superinf. AB (KEIN Penicillin! >Exanthem), Bettruhe, kein Sport 6 Wo., Fluesssigkeit! Herpangina: Cocksackie-Viren >hoch Fieber, Hals/Kopf-Sz, Dysphagie >viele kl. sz.hafte Bläschen (roter Hof) am Gaumenbogen/Uvula/Tonsillen >symptomatisch (Gurgeln mit Aspegic, bei Kindern KI!!!) Stomatitis herpetica: HSV >Sz., Brennen, Fieber >Bläschen + Aphten an Lippen + Mukosa >Abstrich + Serologie >symptomatisch, AB bei Superinf., Acyclovir falls Komplik. (Encephal.) Angina granulotica necroticans: multiple Bakterien >sept. Bild, Ulkus + Nekrosen, Foetor, keine LK! >BE (Agranulozytose) >AB, B-Transfusion, Gurgeln Candida-Mykose/Soor-Stomatitis: fest-haftende bei Entf. blutende weisse Beläge, gerötete Mukosa >Abstrich>top. Antimykotika, Lutschtabletten, Fluconazol syst. (wenn larynx/Ö.) Herpes simplex labialis: HSV-I, Bläschen (auch enoral möglich) + ev. Krusten an Lippe >diverse Symptome, meist guter AZ >klin. Dx. >Desinfektion, Zovirax (Aciclovir)-Salbe od. syst. Perlèche/Faulecken: Eorsionen Lippenwinkel, ev. Krusten >Ursache: Speichelfluss, Prothesen, DM, Vit./Fe--Mangel, AB, Allergie, Lecken >Grunderkrankung, Hautschutz Herpes Zoster: VZV, gruppierte sz-hafte Bläschen, Ulzera+Krusten>Abstrich (PCR: Erregernachweis) >Aciclovir syst., NSAID, Carbamazepin (gg. Neuralgie), lokale AB, ev. top. St. Habituelle Apften: flach-ulzeröse Läsionen mit rotem Hof >Mundspülungen (Aspegic), Tinktur, Steroid-Gel, Thalidomid/Contergan falls s. schwer Blick-Dx: Lingua plicata (Melkersson-Rosenthal-Syndrom), schwarze Haarzunge (nach AB, Steroide etc.), L. geographica (normal, kann bei Psoriasis auftreten), Glossitis rhombica, Zungengrundstruma, Mundwinkelrhagaden (Vitaminmangel), Gingivitis/Peridontitis, Hypertrophe Hydrantoistomatitis, Fordyce-Anomalie, Ranula (Retentionszyste), Leukoplakie, Erythroplakie/M. Bowen, Orale Haar-Zell-L (Präkanzerose), Soor-Stomatitis, Herpes, Hunter Glossitis				
Fremdkörperaspiration	Was aspiriert? Prothese? Husten, Schleim, Zyanose, Stridor, Dyspnoe, Sz., Speichelfluss, FK-Gefühl, Dysphagie, Odynophagie	1. Inspektion (Zyanose, Speichelfluss, Mund/Rachen, ev. Laryngoskopie) 2. Auskultation	Rx-Thorax + Halsweichteile (Gastrographinbreischluck falls V.a. auf FK im Ö.) Pneumologen + Anästhesie (Intub. falls starre E.) informieren PVK legen, O2	1. Endoskopie* bzw. Bronchoskopie 2. Falls drohende Asphyxie: Heimlich-Manöver 3. Cortison, AB ev.	*zuerst flexibel >weicher FK wird in Magen gestossen, sonst mit dann mit starrer E. rausgefischt FK in Nase mit Häckchen entfernen (ev. LA/Sedation)

Ingestion (orale Einnahme tox. Stoffe)	Dysphagie, Odynophagie, Dyspnoe, Dyphonie	1. Inspektion (Zyanose, Mund-Rachen, ev. Laryngoskopie)	1. PVK legen 2. Endoskopie	1. Steroide (hochdosiert) 2. Flüssigkeit i.v. 3. AB (Breiband)	
Akute Atemnot	Atemnot, ev. Zyanose Fragen: FK, Beinschmerz, Panikattacke,	1. Pat. beruhigen, O2 2. Inspektion 3. Anästhesie rufen 4. Je nach Dringlichkeit untersuchen od. direkt Intubieren	> O2 geben, PVK 1. Adrenalin (inhalat., s.c.) 2. Antihistaminikum 3. Cortison 4. Atemweg sichern (Intub., Koniotomie od. Tracheotomie)	Ursache finden + behandeln: BE (D-Dimere u.a.) Rx-Thorax	I.d.R. macht man Tracheotomie (Konio s. selten)
Quincke-Ödem	akutes Oedem d. tieferen BG v. Lippe od. Augenlider od. Zunge od. Rachen, Atemnot, Zyanose	Atemweg sichern! PVK legen, Anästhesie rufen		Adrenalin, Cortison, Anthihist. , ev. Intubation , Noxen weg, bei C1-Estares-Mangel Gabe v. C1-Estares-Konz.	Ursachen: Histaminvermittelt (idop., ASS-Intol, ACE-H., allergisch/IgE, etc.) od. C1-Esterase-Mangel
Stottern	Wie war Entwicklung d. Kindes, Kindheit, psycho-soz. Umfeld (Erwartungen, Disziplin, wenig Geduld, Kritik), <u>Wiederholungen</u> , <u>Dehnungen</u> , <u>Blockierungen</u> , <u>Begleitphänomen</u> (z.B. auf Seite schauen od. Augen schliessen, lautere und höhere Stimme), in gew. Situationen symptomfrei (Speilen mit Puppen, Zählen, etc.), FA	Kind (Sprache, Spielverhalten, Gefühlsausdruck) + Eltern kennenlernen Übers Stottern sprechen HNO-Status Hörtest	Entwicklungsprofil, Sprachverständnis, Artikulation, Freispiel, Kommunikation mit Therapeut, Audit. + visuelle Wahrnehmung	Psychologie: Modifikation Stottern (Ängste, Vermeideverhalten + Anspannung abbauen) Spiel- + Sprechtherapie: Logopädie >Flüssiges Sprechen Wichtig: Eltern miteinbeziehen, ev. Psychotherapie	
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte	Trinken/Saugen erschwert, Übertritt v. Nahrung in Nase, offenes Naseln (Hyperrhinophonie), Palatolalie + -phonie, Ruckverlagerung Zunge, harte Stimmeinsätze, Verschlusslaute schwach (b, p, g, k), oft Tubenfunktionsstörung mit Hörverlust	Inspektion Mund- + Rachen Nase Gehör (Seromukotympanon, Cholesteatom) >Schalleitungsschwerhörigkeit)	Dx Nasalität: nasaler Airflow messen, Pusten/Blasen, Palpation, etc., nasale Endoskopie, Nasometrie Bildgebung (CT)	Saugen/Trinken: Trinkplatte, Flaschensauger, Löffelschoppen Gehör: Parazentese, Paukenröhrchendrainage Chirurgie: Verschluss Lippen, dann Weichgaumen, Später Hardgaumen Logopädie (Artikulation, Luftstrom) + ev. Psychologie	<u>Formen:</u> Lippenkerbe od. -spalte, Lippen-Kiefer-Spalte, Uvula bifida, submukoese Spalte, hintere Gaumenspalte, Lippenkiefergaumenspalte LKG

Tumoren Mundhöhle (Zunge, Lippen, Gaumen, Mundboden, etc.)	RF: Rauchen, Alk, Präkanzerosen (L. planus, Erythro- + Leukoplakie, HPV, etc.), aktinische Keratose/UV, Luftverschmutzung, +FA	Untersuchung Mund (sehr gut auch Sulcus amygdalyglossus und Mundboden) + Rachen Lymphknoten	Panendoskopie mit Biopsien FNP (Zytologie), Biopsie US, CT (Knochen, Larynx), MRI (Weichteile), PET-CT (Staging v.a.)	<u>PE-Ca Mundboden:</u> Teilresektion Mundboden + bds. Neckdissection , Mundbodenrekonstruktion <u>PE-Ca Zungen-Ca:</u> minimale Chirurg. (falls keine Metast.) <u>PE-Ca-Zungengrund:</u> RT-Chemo <u>Leukoplakie, Erythroplakie, Condyloma:</u> Exzision + Biopsie <u>Candida:</u> top. Antimykotika <u>Lichen planus:</u> top. Steroide <u>Orale Haar-Zell-Leukoplakie:</u> Vit.A-Säure, Podophyllin <u>Mucormycosis:</u> radikales Debridement, syst. Antimykotika	90% PE-Ca! DD: Candida-Mykose, Leukoplakie , Fordyce-Anomalie, Lichen planus , orale Haarzell-Leukoplakie, Lingua geografica, Haarzunge, Erythroplakie , Hämangiom, Lymphangiom, Pyogenes granulom, HSV, M. Wegener, Mukormycosis, Condyloma acuminata
Kiefergelenkserkrankung	Kiefergelenksknacken, Sz., (beim Kaufen), Muskel-Sz., Trismus, Ohren-Sz., Schwellung, Zähneknirschen, Zahn-Sz., Systemerkrankungen (RA, >Morgensteifigkeit, Schwellung, Rheumaknoten, Deformation, etc.), Fieber (infekt. Arthritis), Dysphagie, Atemnot <u>Hinweise f. Tumor:</u> spontane Okklusionsstörung, Mittellinienabweichung v. UK bei Mundöffnung <u>RF:</u> Alter, Prothese, Mangelernährung, Infekte, Osteoporose, chron. Reize, Zahnverlust, Karies/Hygiene <u>RED FLAGS:</u> Trismus, Atemnot, F. canina Abszess, Dysphagie, CRP>100	Inspektion UK + OK (Symmetrie, Dysgnathie, Kammatrophy, Schwellung, Rötung), passive + aktive Beweglichkeit testen, Gelenk palpieren , Mundöffnung messen , Knacken hörbar? Trismus? Mund + Rachen inspizieren , Zähne (E., Abszess,), Alveolarkämme (Dicke/Atrophie), Lymphknoten	Labor (CRP, LK), US, CT (bei Logenabszess v.a.!), Zahn-Rx *falls kein Fieber, kein Trismus, akute Zahn-Sz., kein Eiterraustritt >keine AB sondern abwarten	<u>Bruxismus:</u> Stressabbau, Physio, Okklusionsschiene <u>Diskopathie:</u> Physio, Arthroskopie + Lavage, Hyaluronsäure Diskettomie/Arthroplastik <u>Arthrose:</u> NSAID, Steroide, Arthroplastik, Resektion Ankylosemasse (bei Ankylose) Synoviale Chondromatose: Arthrotomie, Entfernung Gelenkskörper, Resektion Synovia <u>Tumor:</u> je nach Typ Dentogene Infektion: AB*, Drainage (Abszess) >Abstrich, Spülung, Zahnbehandlung <u>Kieferkammatrophy:</u> Implantate, Hygiene, Knochenaufbau <u>Dysgnathie:</u> Chirurgie (bilat. sag. Schnitt od. Le-Fort-Osteotomie od. Mandibulo-maxill. Osteotomie), Genioplastik (Weichteile)	Bruxismus: Zähneknirschen Diskopathie: Luxation, Diskusverlagerung >Knacken,, Arthrose: Sz., z.T. Trismus, im Extremfall Ankylose mit Trismus Arthritis: i.R. RA od. Psoriasis z.B., infektiös, reaktiv od. postinfektiös Tumor: Synoviale Chondromatose, Osteochondrom, Sarkom Dentogene Infektion: submukoöser Abszess, Fossa canina-Abszess, Logenabszess Kieferkammatrophy: Reduktion Gesichtshöhe weil Atrophie/ Degeneration UK/OK Dysgnathie: Kieferfehlstellungen >Pro- + Retrognathie d. UK/OK, falls 6er-Zahn des OK nicht auf Höhe des 1. Molaren des UK zu liegen kommt bei Neutralbiss.
Periphere Fazialisparese	Trockenes Auge, Sz. Auge, Geschmacksverlust, keine Tränen mehr, Hypakusis, Probleme mit Mundschluss/Essen <u>RF:</u> Infekt (Ohr, obere Atemwege), Trauma, Schwellung Parotis (Tumor)	Inspektion (Bell-Phänomen/Parese, Ptose, Nasolabialfalte) Auge (Schirmertest, Spalt, Auflicht/Fluoreszin) Gehör (Hörtest, Stimmgabeln, Otoskopie, Stapediusreflex!) Mund (Mundschluss, Fazialistest, Geschmack testen) Neurostatus: Fazialistesten (periphere vs. zentrale Parese), Geschmack, Gehör	BE, Serologien (Borreliose, HSV, HIV, , ev. LP Falls Persistenz >3Mte > MRI (Abklärung Parotis-Tumor)	Je nach Ursache! 1. Prednison Tbl. (10T.) 2. ev. Valtrex (Valaciclovir)* 3. Augentropfen /Salbe + Uhrglasverband falls Bell-Parese *falls Virus, auch wenn nicht erwiesen in Serologie!	<u>Ursachen:</u> entzündlich/infektiös, Traumatisch, Tumorbedingt <u>Periphere FP:</u> Stirnmuskulatur ausgefallen (meist idiopath., infektiös >Borreliose, HSV, HIV), traumatisch <u>Zentrale FP:</u> Stirnmuskulatur intakt, ZNS-Problem (Tumor, MS, CVI)

RACHEN					
Akute Tonsillitis (nur Tonsillen/Mandeln)	Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), meist unilateral., akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung, klossige Sprache	Inspektion Mund + Rachen (weissl. nicht-konfl. Beläge >Stippchen, Schwellung Tonsillen, Rötung) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Tonsillenabstrich + Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen	AB (Augmentin, falls bakteriell), Lutschtabletten (Analgesie) NSAID ev.	In ersten 24h ansteckend (Tröpfchen). <u>Syn</u> : Angina tonsillaris/lacunaris <u>Erreger</u> : meist bakteriell (Strep. A), selten EBV (starke Beläge, Grippe-Symp., Müdigkeit, langer Verlauf)
Peritonsillarabszess, Parapharyngealabszess, Retropharyngealabszess	Meist i.R. od. nach akuter Tonsillitis od. Zahnproblem/behandlung, Hals-Sz., meist unilateral, Odyno- bis Dysphagie, Trismus, hohes Fieber, Aphagie, red. AZ <u>Retroph.Abszess</u> : Torticollis, Dyspnoe, weniger Sz als bei Para- oder Peritonsillärabszess	Inspektion Mund + Rachen (<u>Peri</u> : einseitige Rötung + Schwellung Uvula/Wiechgaumen+ hinter Tonsille mit Verlagerung Gaumensegel >Kulissenph., <u>Para</u> : enorale parapharyngeale Schwellung, <u>Retro</u> : enorale prävertebrale Schwellung). Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (ev. Schwellung + Sz.) Ohr + Nase untersuchen	Hospitalisation, PVK + BE (CRP, BSG, Linksversch.), Fieber <u>Peritonsillarabszess</u> : i.d.R. klinische Dx , CT (KM) möglich <u>Parapharyngealabszess</u> : CT (KM) <u>Retropharyngealabszess</u> : CT (KM) (US schlecht)	<u>Peritonsillarabszess</u> 1. Spaltung Abszess (Drainage) in LA + tgl. Spreizen + Spülen od. Abszess-TE (à Chaud), AB , Kontrollen! 2. Falls Spaltung TE nach 3 Mt. (à froid) empfohlen <u>Parapharyngealabszess</u> : Abszessdrainage (Spaltung) + ev. TE, AB (i.v.) <u>Retropharyngealabszess</u> : „“, AB i.v.	
Chron. Tonsillitis	Fibrosierung d. Tonsillen oft bei Rauchern, sz.-hafte vernarbte Tonsillen, zeigt s. als rezidiv. Tonsillitiden od. ohne Symptome, Abgeschlagenheit, Halitosis	Inspektion Mund + Rachen (kleine derbe Tonsillen, schlecht luxierbar, peritonsilläre Rötung) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals Ohr + Nase untersuchen	Labor (BSG + CRP erhöht, Linksverschiebung), Abstrich ev.	TE (falls Dx. klar und Pat.wunsch)	Rezidiv. Infekte d. Tonsillen >Fibrosierung
Akute Angina (ganzer Waldeyerscher Rachenring)	Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung	Inspektion Mund + Rachen (Rötung/Schwellung Rachen/Tonsillen/etc, ev. Beläge an Rachenhinterwand) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Rachen- + Tonsillenabstrich (Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen	AB (Augmentin, falls bakteriell), Lutschtabletten (Analgesie) NSAID ev.	
Akute Pharyngitis	Odynophagie, Hals-Sz., Symptome eines Infektes d. oberen Luftwege (LK, Fieber, Kopf-Sz., Husten, NAB)	Inspektion Mund + Rachen (Starke Rötung Rachen, ev. schleimige Beläge) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals Ohr + Nase untersuchen	Ev. Rachen-Abstrich	Kein Fieber: NSAID , Gurgeln (antisept.), Hausmittel , viel Trinken Fieber: AB (Augmentin) Ist fast immer banal! Häufig!	Oft viral (Influenza- od. Parainfl.-Viren), z.T. bakteriell Meist banale Pharyngitis! 50% d. Hals-Sz. wegen banaler Ph.

Chron. Pharyngitis	Räusperzwang, Reizhusten, FK-Gefühl, i.d.R. keine Hals-Sz. <u>RF</u> : Langfristige Exposition gg. noxen (Rauchen, Alk, Chemikalien, Reizgase), Mundatmung, chron. Sinusitis	Inspektion Mund + Rachen (granulierte od. ganz glatte Rachenhinterwand) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Endoskopie Nase (Septumdeviation, Muschelhyperplasie, etc.)	1. Noxen weg 2. Befeuchtung Atemwege (Inhalation >Salbei, super!), Lutschtabletten, Trinken 3. Operation (falls anatom. Problem)	
Scharlach	Hals-Sz., Odynophagie, Otalgie, Husten, hohes Fieber, LK, Enanthem (Rötung Zunge + Mund), Exanthem	Inspektion Mund + Rachen (initial weissl. belegt, dann Himbeerzunge, Tonsillen dunkelrot geschwollen, Rachen gerötet) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen Haut : stechnadelkopf-grosses Exanthem	Strepto-Schnelltest Fieber messen	AB (Augmentin)	B-Hämolysierende Strept. A (wie Akute Tonsillitis)
Nekrotisierende Faszitis	Bleibt nicht in Logen drin, Gefahr einer Mediastinitis	Inspektion und Mund und Rachen, LK, Hals Inspektion und Palpation, Nase und Ohren untersuchen	CT/MRI	AB oder Notfallcervikotomie	
Tonsillennachblutung	Blutung aus Mund, ev. Bluthusten, Dyspnoe, ev. kreislaufinstabil, ev. Schock (Pat. versterben am Verstickten von Blut)	1. Inspektion Tonsillenlogen 2. ev. Laryngoskopie	> Hospitalisation: NOTFALL! 1. grosslumiges PVK (sofort), Testblut 2. Kompression (Tamponade, Finger) 3. Intubation (Gefahr Aspiration)	1. Naht 2. Ligatur A. carotis externa 3. Embolisation	Falls nur leichte Nachblutung (sog. Warnblutung) >Hospital. zur Überwachung (engmaschige Rachenkontrollen, grosslumiger Zugang), falls erneute Blutung OP
LARYNX					
Stimm lippenprobleme	Stimmanamnese (Heiserkeit, stimme leiser, Aphonie, Diplophonie >Polyp, Chrott im Hals, etc.), Heiserkeit (einseitige Stimm lippenlähmung), Dyspnoe (bds. Lähmung), Infekt, Rauchen, Alk, Psyche/Stress, B-Symptome	Stimmstatus : auditiv >Standardlesetext, akustisch >Stimmfeld- + -schall-Analyse Laryngo- + Stroboskopie Gehör testen Lymphknoten	Endoskopie	Je nach Ursache Chirurgie (Tumoren, bds. Stimm lippenlähmung), ev. Chemo , ev. Silikoninjektion (Verbesserung Stimm lippenanschluss), Logopädie/Stimmtherapie (Heiserkeit, einseitige Stimm lippenlähmung), Psychologie (funkt. Störungen) *RT, Laser ev.	<u>Pathologien</u> Stimm lippenlähmung Benigner Tumor (Papillom (evtl. Dyspnoe)/ HPV , Zyste (wechselnde Stimme), Polyp (diplophon)) Maligner Tumor (Stimm lippen-Ca*) Funktionelle Dysphonie (keine organ. Ursache od. organ. Problem als Folge v. Belastung/Stress)

Akute Laryngitis	Hals-Sz., rauhe/belegte/heisere Stimme, oft Zeichen v. Infekt d. oberen Luftwege (Rhinitis, Husten, etc.), evtl. Atemnot (NOTFALL!!!)	Inspektion Mund + Rachen Laryngoskopie (Schleimhautschwellung, starke Rötung, Schleim) Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr		<u>Symptomatisch</u> Stimmerschonung, Hausmittel, viel Trinken, Inhalationen (NaCl, Salbei), NSAID Infekt dauert ohne + mit Arzt gleich lang.	
Chron. Laryngitis	Heiserkeit, FK-Gefühl, tiefe Stimme RF: chron. Reize (Nikotin)	Inspektion Mund + Rachen Laryngoskopie (trockene Schleimhaut, zäher Schleim mit Fibrinbelägen, Stimmlippen gerötet) Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr		1. Noxen weg (Nikotinstopp) 2. Inhalation (Acetylcystein >Expectorans, NaCl, Cortison) 3. viel Trinken 4. NSAR, PPI falls Reflux, 5. Stimmtherapie	
Epiglottitis (Kinder Hib, Erwachsene Staph aureus, Streptokokken etc.)	Hohes Fieber, inspirat. Stridor, Atemnot, z.T. Heiserkeit + Husten, klossige Sprache (Hot-Potatoe), Odynophagie, Speichelfluss	Inspektion* Mund + Rachen (Rachenwand gerötet) Laryngoskopie (Epiglottis stark geschwollen + hochrot >rote Kirsche, ev. Abszess) Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr	BE (CRP, Linksversch.), Blutkultur Anästhesie (Intubation, oft als 1. Massnahme um Atemweg zu sichern, denn Lage kann s. abrupt verschlimmern!), ev. CT Hospitalisation	NSAID, Adrenalin Intubation, AB (Augmentin), Prophylaxe: Impfung gg. H. infl. Typ B (dann 0% Mortalität)	Lebensbedrohlich in 10%! *vorsichtig denn reflekt. Atemwegsverlegung möglich! DD: Pseudokrupp (viral), Krupp (Diphtherie)
Pseudokrupp / Akute subglott. Laryngitis)	Meist Säuglinge + Kleinkinder, oft Frühling od. Herbst, abends/nachts, trockenbellender rauher Husten, insp. Stridor, Atemnot, Zyanose, Heiserkeit, ev. Fieber	Inspektion Mund + Rachen Laryngoskopie (subglott. Stenose) Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr	BE (keine Leukozytose)	Anfeuchtung Atemluft, Flüssigkeit, orale Steroide, Inhalation Adrenalin (Abschwellung)	<u>Echter Krupp:</u> falls Diphtherie, enorm selten!
Laryngo-Tracheitis	Sporadisch (keine jahreszeitl. Häufung), Säuglinge + Kleinkinder, langsamer Beginn mit Rhinitis/Pharyngitis, in- + expirat. Stridor, RG über Lungen, ev. Fieber(Verschlimmerung kann auch plötzlich nachts erfolgen)	Inspektion Mund + Rachen (Mukosa gerötet) Laryngoskopie (Mukosa im ganzen Trakt gerötet, Stimmlippen + subglottisch gerötet + geschwollen) Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr	BE (Linksversch.), ev. Intubation	1. AB (Augmentin), Acetylcystein 2. Anfeuchtung Atemluft, Flüssigkeit	Gefahr f. Atemwege!
NASE					
Riechstörung	Hyposmie, Anosmie, Hyperosmie, spez. Anosmie, Parosmie/Kakosmie, Phantosmie, fragen ob Trigeminus (Temp., Sz., etc. ok), fragen ob Geschmack (5 Qualitäten) ok, Rauchen, Alk	Inspektion Nase Rhinoskopie (E., Blutung, Septum, Polypen, Tumor) Mund/Rachen untersuchen	Riech- + Schmecktest (Pat. verwechseln beides oft) Nasale Endoskopie (Polypen, Tumoren, Schleimhaut) Serologie	Je nach Ursache - Chirurgie - Noxenstopp (Medi, Rauchen) - Steroide top. - Smell Training	Oft keine kausale Behandlung, Prognose eher gut weil Riech-EP s. regeneriert Gute Prognose bei Riechverlust wenn: Parosmie, kurze Erkrankungsdauer, junges Alter, nicht rauchen, hoher Initialscore

	Trigger: Polypen, Infekte, SHT, Alter, Alzheimer, Parkinson, Psyche, Medis (Antimykotika)		MRI, CT Neurolog. Konsil, ev. Psychiatrie		
Epistaxis	Nasenbluten, ev. Bluthusten, Dyspnoe, ev. kreislaufunstable, ev. Schock Trigger: Trauma, trockene Mukosa, Rezidiv, Antikoagul., FK, Tumor, Hypertonie, trockene Luft, Infekt	1. Pat. beruhigen , aufrecht hinsetzen , Blut nicht schlucken 2. Kompression Nasenflügel 3. Eiskrawatte (Nacken)	Monitoring (BD u.a.) PVK + BE (Testblut u.a.) Endoskopie (falls rezidiv.) Angiographie ev., ev. CT/MRI	1. Inspektion + Nase reinigen (Koagel raus) unter LA 2. Blutungsstopp : Verätzung, Kauterisation, Tamponade, Ligatur, Embolisation, OPs falls alles nichts bringt, Tamponade* 3. Detamponade (nach 2-3 T.) 4. Schnelzverbot 7 T., keine Hitze	Häufig, selten gefährlich (Gesichts-Fx, M. Osler, Aspiration v. Blut), meist selbstlimitierend *ev. AB , bei bds. Tamponade immer
Akute Rhinosinusitis ARS (<4 Wo.)	<u>Viral</u> : Rhinorrhoe, Dyspnoe/NAB, Hyposmie, Gesichts-Sz. (beim Bücken u.a.), OLW-Infekt, Fieber, Husten, Halsweh, Kopf-Sz., Otalgie, Dauer(<8-10T.), guter AZ meist, Asthma, Zahnweh (dentogene S.) <u>Bakt. ARS, ev. mit Komplikation</u> : Symptome wie oben, aber Verschlimmerung nach 3-5 T. + >10T. Dauer, red. AZ, grünelbes Sekret, ev. Meningismus, Weichteilschwellung, Zahn-Sz., sept. Bild	Inspektion Palpation : Nervenaustrittspunkte, Klopfdolenz NNH, Pat. soll s. bücken Rhinoskopie (Sekret, E., Schwellung) Racheninspektion (Drip? Rötung) Untersuchung Ohren (Otoskopie, Palpation, Stimmgabel + Hörtest) Ev. Lunge (Auskult. bei Husten) Lymphknoten	Ist eine klin. Dx, aber Facharzt kann zusätzlich machen: Diaphanoskopie , ev. BE Ev. NPS (klin. Dx reich aber), Endoskopie , (Rx/CT erst bei Persistenz od. Komplikation.) * Kontrolltermin (nach 1 Wo.), falls keine Besserung: wohl bakt. Infekt > AB geben	VIRALE ARS* : sympt. Th. <u>Lokal</u> : Abschwellende Trpf. (Xylomethazolin/Otrivin), NaCl -Spülungen, Steroid-Spray , Crema <u>Systemisch</u> : Abschwellende Tbl. (Ephrin/ Phenylephrin) > Otrinol/Rhinopront , NSAID <u>Inhalationen</u> : Aether. Oele BAKTERIELLE ARS : wie oben, zusätzlich AB (B-Lactam/Penicillin) Mukolytika + Antihist. Kein Effekt	Meist (90%!) i.R. viraler Infekte, dann <10T + Symptome nehmen nicht zu nach 3-5T. Komplette Erholung AB gibt man nur wenn s. schwere Symptomatik (auch wenn <10 T.) od. falls Symptome >10T. od. wenn sympt. Th. bei V.a. viralen Infekt nicht greift. Zeichen f. bakt. RS: Zahn-Sz., purulentes Sekret Weitere Formen: Pilzsinusitis , dentogene S. , Rhinosclerom , atrophe Rhinitis/Rh. Sicca , Empty Nose , Leishmania-RS , Baro-S. , Bade-S. , Silent Sinus Sy , hormonelle RS , Medikamentöse RS , idiopath. RS
Chron. Rhinosinusitis CRS (>12 Wo.)	Symptome wie bei ARS aber mehrere Wo.! ev., Polypen, Dauer (>12 Wo.!)		Sinuspunktat (Gramfärbung, Kultur, Resistenz) BE Endoskopie (Polypen, RF), CT/Rx Evtl. Allergietest	Top. + syst. Steroide , selten AB (aber nur gut wenn 8-12 Wo.!), Antihistaminika falls Juckreiz, NaCl Mukolytika + Abschwellende Medis kein Effekt	Oft weil Polypen Nicht komplette Erholung
Allergische Rhinosinusitis	Typischerweise JUCKREIZ, NAB, Rhinorrhoe (wässrig-klares Sekret), Niessreiz, ev. Asthma, Konjunktivitis, Allergien/ Trigger (Pollen, Milben, etc.), oft +FA, oft ganzer HNO-Bereich betroffen, Jucken im Ohr, postnasal-Drip, Husten		Ev. Prick- + Patchtest BE (IgE) SIT in Erwägung ziehen!	Intermittierende AR (<4T/Wo od. <4 Wo) Orale H1-Blocker , falls s. starke Symptomatik ev. top. Steroide Persistierende AR (>4T/Wo + >Wo) Top. Steroide* + ev. orale H1-Blocker , falls starke Obstruktion kurzzeitig orale Steroide	*am besten an lat. Nasenwand sprayen (zur Osteom. Einheit) DD: idiopat. Rhinosinusitis Anfallsartig waessrige Rhinorrhoe, NAB, Niessreiz (wie allerg. Rhinitis), Trigger: Kalte Luft, heisse Getraenke, Schwefelstoffe

Polypsis nasi	Abgeschlagenheit, NAB, Obstruktion, Rhinorrhoe, Post-Nasal-Drip, <u>Hyposmie/Anosmie</u> , Kopf- + <u>Gesichts-Sz.</u>	Inspektion Palpation: Nervenaustrittspunkte, Klopfdolenz NNH, Pat. soll s. bücken Rhinoskopie (Sekret, E., RF) Racheninspektion (Drip? Rötung, Polyp) Untersuchung Ohren (Otoskopie, Palpation, Stimmgabel + Hörtest) Ev. Lunge (Auskult. bei Husten) Lymphknoten	Therapie: Chirurg. Entfernung	Bilaterale Polypen bei Kindern >CF, prim. Ziliendyskinesie Systemerkrankungen mit Polypen: Churg-Strauss, M. Widal DD: Schneiderpapillom (Einstülpungen, Präkanzerose v. PE-Ca!) DD: Mucozele (Mukosa-Ausstülpung mit Mukus)	
Tumoren	<u>Unilateral, NAB, Epistaxis, Anosmie</u> , Obstruktion, oft <u>Hypästhesie V2 + Epiphora</u> (Tränenträufeln), LK-Schwellung B-Symptome		Biopsie	Chirurgie, ev. RT/Chemo	<u>Haut:</u> Basaliom (H-Zone), Spinaliom, Melanom <u>Nasenhöhle:</u> PE-Ca, Adeno-Ca, Speicheldrüsen-Ca , Melanom, Lymphom
Entzündungen	Rosazea (Rhinophym) H. Zoster (Hutchinson-Z.) Erysipel (flache Rötung/Schwellung, Ohr läppchen beteiligt)		Furunkel (tiefe E. v. Haarfollikel), SLE (Schmetterlingserythem) Lupus pernio (Sarkoidose an Nase, notig, z.T. Ulzera) Rhinophym (i.R. Talgdrüsenhyperplasie: Tetracyclin/Isotretinoid od. Dermabrasie/Laser)		
Anatomische Probleme	Septumdeviation/Schiefnase Leistenbildung		Nasenform Muschelhyperplasie Polypen Adenoidhyperplasie bei Kindern (Schnarchen, chronische Mundatmung)		
OSAS	Schlaf, Schnarchen, Nasen- od. Mundatmung, Tagesschläfrigkeit, intellektueller Leistungsabfall, Impotenz, Enuresis, Hypertonie	Mund + Rachen (Tonsillenhypertrophie, Retrognathie, grosse Uvula) Nase (Septumdeviation, Polypen), Laryngoskopie	Endoskopie mit Müller-Manöver (Obstruktionstest), Polysomnographie, Schlaflabor Einstufung Schweregrad: AHI-Index (Apnoe-Hypopnoe-Ereignisse)	Konservativ: Gewichtsred., Trigger vermeiden (Alk, Rauchen, Sedativa), Schlafposition (keine Rückenlage), orale + nasale Devices, CPAP-Beatmung Chirurgisch: Septumplastik, Chonchotomie, NNH-Op, TE, Weichgaumen-Straffung, Hyoidsuspension, Tracheotomie >multilevel-Chirurgie M.d.W.	<u>Pulsoxymetrie:</u> viele Falsch-Negative! DD: habituelles Schnarchen (Benigne), UARS
OHR					
Schwerhörigkeit	<u>Anamnese</u> Otorrhoe, Otalgie, Hypakusis-Grad, Tinnitus, Schwindel, Fieber, AZ, etc. RF: Alter, DM!, +FA, Pegel/dB, Knalltrauma, rezidiv. Otitiden, Infekte obere Atemwege <u>Status</u>	<u>Untersuchungen</u> - Audiometrie (Reinton, Sprache), - Tympanogramm - Stapediusreflexe - OAE - ERA - ev. Bildgebung (CT, MRI)	<u>Therapie</u> Schallempfindungsproblem: Presbyakusis (Schalleitung- + Schallempf v.a. f. hohe Freq. progressiv langsam verschlechtert, symmetrisch, bds., Hörschwelle höher, Otoskopie + Stimmgabeltests. normal) > Hörgerät falls >40 dB Infekte (Röteln, Syphilis) > AB od. sympt. (viral) FG, Knalltrauma (CS-Senke) Hörsturz Ototox. Medis (Amiodaron, AB etc.) >Medi absetzen , ev. Hörgerät	<u>HÖRGERÄT</u> Mildes Schallempfindungsproblem: <u>Schallverstärker-Hörgerät</u> (ausser s. ausgeprägt) od. <u>Knochen vibrator/BAHA</u> Schwere Schallempfindungsstörung <u>Cochlea-Implantat</u> (präop. Bildgebung nötig, CT + MRI, bei bds <30dB Hörschwelle), <u>Hybrid-CI</u> (falls	

Zoster oticus	Sz., Bläschen am Ohr, red. AZ, Fieber, ev. Fazialisparese, ev. Geschmacksstörungen, ev. Hypakusis, ev. Rhinorrhoe, ev. Schwindel	Inspektion äusseres Ohr: Bläschen, Krusten Palpation Gehör testen: Stimmgabel, Hörtest Otoskopie (ev. Otitis externa +/- od. media) Vestibularsystem testen: Nystagmus, ev. Kalorik Neurostatus: Sensibilität (Dermatom), Fazialisfunktion, Geschmack, Romberg	Hospitalisation, PVK, ev. Ophta-Konsil 1. Abstrich (Bläschengrund) 2. Serologie (AK)	1. Antivirale Th. Valaciclovir* 2. Analgesie (NSAID) 3. Zink-Tinktur lokal (Wundheilung) *bei Alten auch noch 5-7 T. nach Syptombeginn um Risiko für postzosterische Neuralgie zu senken.	
FK od. Cerumen obturans	FK-Gefühl, Hypakusis, ev. Rhinorrhoe, oft nach Baden/ Duschen, Tinnitus	Inspektion äusseres Ohr Palpation Gehör testen: Weber (lat. ins Kranke), Rinne (leicht + od. neg. am betroffenen Ohr), Hörtest Otoskopie	*Pat. über Risiken aufklären (Sz., Schwindel, Perf.)	1. Entfernung Cerumen (Sauger, Häkchen, Zange, Spülung* falls keine TF-Perf.!) 2. Entfernung FK (in LA/Xylocainsray) Kinder: ev. Sedation nötig!	<u>Cerumen:</u> Wasser macht, dass Cerumen aufquillt >nimmt Cerumen stärker wahr <u>FK:</u> Stimmgabeltests o.B. <u>Zecke:</u> Xylocainspray + mit Zange entfernen
Akute Otitis media	Kürzlich Krank (obere Atemwege >Rhinitis, Husten, Halsweh), Hypakusis, hoch Fieber, starke Otalgie, ev. Otorrhoe, red. AZ, meist kein Schwindel <u>RF:</u> Infekt ob. Atemwege	Palpation: Tragusdruck- + zug (eher Otitis externa), Mastoid Gehör testen: Stimmgabel* + Hörtest Otoskopie (gerötetes TF, ev. Perf.) Lymphknoten Ev. Nase untersuchen Meningismus * Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.)	<u>Beginnende O. media</u> 1. Symptomat. Th.: Analgesie + abschwellender Nasenspray (Otrivin) 2. Kontrolltermin in 24h! >AB (Augmentin) falls keine Besserung <u>Komplizierte O. media: Schwindel, s. starke Sz. od. Perzeptions.hörigkeit:</u> 1. Parazentese/Paukendrainage, AB i.v. <u>Komplizierte O. media mit Mastoiditis, Fazialisparese od. ZNS-Problem >CT</u> 1. Parazentese* + Mastoidektomie (Eiterablass) falls Mastoiditis 2. Hospitalisation + PVK: AB i.v., Analgesie, Tropfen (Abschwellung, Desinfektion) 3. Regelmässige Reinigung Gehörgang + Spülung	Komplikationen: TF-Perf., Hörverlust, Akute Mastoiditis: absehendes Ohr + Rötung Mastoidregion *nie im hinteren oberen Quadranten - Labyrinthitis: Schwindel - Cochlea-Beteiligung: Innenohrschwerhörigkeit - ZNS-Beteiligung: Meningitis, Sinusv.thrombose, Enzephalitis, Abszess, etc. Falls drohende Komplikation od. schlechte Gefühl (Schwindel, Schallempfindungsstörung, etc.,) kann man auch sofort schon AB geben + muss nicht 24h warten.	
Otitis media chronica simplex	Keine Schmerzen, Hypakusis (sog. sz-lose Hörminderung), Otorrhoe (bei Erkältung + Kontakt mit H2O) <u>Ursachen</u> erfragen: O. media vorgängig, Trauma	Palpation: Tragus, Mastoid Gehör testen: Stimmgabel* + Hörtest Otoskopie (gerötetes TF, <u>zentrale Perf.</u> , Otorrhoe) Lymphknoten	*Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.) Ev. Audiometrie (Transmissionss.) Tympanometrie (abgeflacht) Stapediusreflexe (schwach) OAE, ERA	1. AB p.o. + Trpf. 2. Falls Pilz: Antimykotika -Trpf. od. Essigsäure (sz.haft) 3. Tympanoplastik (Verschluss TF) 4. ev. Ossikuloplastik (falls G-Knöchelchen zerstört) Pat. soll kein H2O ins Ohr lassen!	<u>Pathogenese:</u> ist Folge einer bleibenden Perf. nach O. media, Trauma, Dysfunktion Tuba eu., etc.
O. media chronica seromucosa	Schmerzlose Hoerminderung, keine Infekzeichen, kein Krankheitsgefühl	Gehör testen: Stimmgabel* + Hörtest Otoskopie (TF nicht gerötet! Keine Perf., Paukenerguss) Lymphknoten	Endoskopie (Rachen >Tumor, Adenoid, etc. suchen)	Ausschluss Tumor, Tubentraining, ev. Parazentese/Paukendrainage, Adenotomie	

Otitis media chronica cholesteatosa / Cholestatom	Keine Schmerzen, Hypakusis (sog. sz-lose Hörminderung), Otorrhoe (bei Erkältung + Kontakt mit H2O) <u>Ursachen:</u> Trauma, rezidiv. O., kongenital, etc. (Klinik wie bei O. media ch. s., bei Exazerb. wie akute O.M.!)	Palpation: Tragusdruck- + zug, Mastoid Gehör testen: Stimmgabel* + Hörtest Otoskopie (randständige TF-Perf., Retraktion + PE-Debris/Cholesteatom >typisch oberer hinterer Q., Otorrhoe) Neurostatus: Fazialis, Nystagmus Lymphknoten	*Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.) Audiometrie (Transmissionss.) Tympanometrie (abgeflacht) Stapediusreflexe (schwach) OAE, ERA	Cholesteatom-Entfernung, TF-Verschluss , ev. Ossikuloplasti	<u>Pathogenese:</u> Belüftungsstörung Mittelohr (TF-Perf. nach rezidiv. Otitiden od. Dysfunktion T. eustachi >Unterdruck >saugt EP rein), kongenitales Cholesteatom (EP-Inseln am falschen Ort), posttraumat. wenn randständige Perf. Oft Infekte, Komplikationen wie bei akuter O. media möglich!
Otitis externa	Dumpfes Gehör (nur s. wenig Hypakusis), Otagie, kein Schwindel, ev. Rhinorrhoe, kein Tinnitus, guter AZ, oft nach Baden/Schwimmbad, ev. Juckreiz (Pilz) RF: Baden, perf. O. media, DM! (Osteomyelitis), Schwimmer (häufig auch Hyperostosen/Exostosen)	Inspektion äusseres Ohr Palpation: Tragusdruck-Sz.! Mastoidklopfdolenz Gehör testen: Weber ins Kranke, Rinne knapp + od. neg., Hörtest (Hypakusis) Otoskopie (E. Gehörgang) Lymphknoten	*falls Gehörgang zu eng <u>Therapie</u> 1. Reinigung + Desinfektion 2. AB-Tropfen (bei TF-Perf. KI >p.o.) od. Meschen-Einlage* 3.. Analgesie (Audio: eher o.B., Tympanometrie + Stapediusreflexe o.B.)	Bakt. O. ext. circumscripta: Furunkel/Bibeli im Gehörgang: Inzision in LA, AB Trpf. + p.o. O. externa mi Pilz: dann typischerweise Juckreiz > Desinfektion, Antimykotikum od. Essig-Trpf., keine AB! O. externa maligna/necroticans: falls DM vorliegt > syst. AB Komplizierte O. externa: O. media mit TF, Gehörgangshyperostose (oft bei Schwimmern!), DM	
Otosklerose	Hypakusis, sonst keine Symptome, Masern gehabt? RF: Masernvirus ev., SS	Inspektion äusseres Ohr Palpation Gehör testen: Stimmgabeltests*, Hörtest (Hypakusis) Otoskopie o.B Lymphknoten	Audiometrie (Transmissionss- + dann zusätzlich Perzeptionss.) Tympanometrie (abgeflacht) Stapediusreflexe (schwach) OAE, ERA	1. Stapedektomie (Ersatz durch Prothese) od. Hörgerät (falls schlimm CI sonst Schalleitungshörgerät) (Tauchen KI, Fliegen ok)	*zu Beginn nur Luftleitungs-, dann zusätzlich Schallempfindungsstörung mit der Zeit <u>Pathogenese:</u> Verknöcherung Stapes in ovalem Fenster nach Infekt
Tumoren (Ohrhaut)	Sz., Vorläuferläsion, B-Symptome, weitere Tumoren	Inspektion äusseres Ohr: ABCDE (Melanom) Palpation Gehör testen, Otoskopie	<u>Untersuchungen:</u> Biopsie <u>Therapie</u> 1. Exzision i.d.R., ev. RT 2. Staging	Chondrodermatitis nodularis Winkler: benigne, sz.hafters Knötchen Ohr läppchen Melanom: meist pigmentiert, unscharf Basaliom: lokal destruktiv, oft perlgrau-artige Knoten, zentrale Eindellung Spinaliom: rötlich, ulzerierend	

VESTIBULARSYSTEM

Akutes Vestibularisdefizit	Akuter heftiger permanenter Drehschwindel, Gangunsicherheit, Nausea, Erbrechen, Ohr intakt, keine Provokationsmanöver, keine neurolog. Zeichen, mehrere Tage, oft nach viralem Infekt, einmaliges Ereignis <u>Trigger</u> : viraler Infekt! vaskulär	Frenzelbrille/Nystagmus (horizont. Spontannystagmus zur gesunden Seite) Kalorik (keine Erregbarkeit/ Untererregbarkeit, Beeinflussung d. Nystagmus) Neurostatus : Gang (Ataxie), Romberg (Falltendenz zur kranken Seite), Unterberger (Abweichung zur kranken Seite), FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik Gehör (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest) o.B. HINTS peripher: Head impuls abnormal zur kranken Seite, Nystagmus unidirektional zur gesunden Seite, Test of skew keine Vertikaldivergenz HINTS zentral: HI normal, Nystagmus bidirektional, TS Vetrikaldivergenz		PVK f. Leitung, ev. Hospitalisation 1. Antiemetika (Primperan) 2. Vestibuläre Physio (sobald akute Phase durch):	<u>Prognose</u> : gut, nach Tagen bis Wo. verschwindet Symptomatik durch Training
Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel	Plötzlicher Beginn >Drehschwindel, Sec. bis Minuten, Kopfbewegungen (zur kranken Seite) lösen es aus, Übelkeit, ev. Erbrechen, Ataxie, viele Wiederholungen, Tage bis Wochen	Frenzelbrille/Nystagmus (transit. rotatorischer Nystagmus) >o.B. Neurostatus : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik >o.B. Gehör (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest) >o.B.	Ev. Kalorik Dix-Hallpike-Manöver (Kopf drehen zur kranken Seite, dann überhängend abliegen) : >Nystagmus provozierbar!	1. Vestibuläre Physio (Epley- (Kopf zur betroffenen Seite dann seitlich abliegen etc.)+ Semont (Kopf zur gesunden Seite drehen dann abliegen etc.)-Manöver) 2. Chirurgie (selten, wenn Physio erfolglos)	<u>Pathogenese</u> : Otolithen im Bogengang bzw. auf Cupula weil Trauma/Schleudertrauma/Vestibularis-Neuritis/Idopathisch (Frauen oft) <u>Prognose</u> : gut, z.T. Rezidive
M. Menière	<u>Trias</u> : Plötzlich Schwindel (stundenlang), Tinnitus, Hypakusis (fluktuierend, v.a. Tieftonbereich), Erbrechen, Drop-Attacks (Sturz bei Bewusstst. da plötzlicher Tonusverlust), meist chron. (immer wieder)	Frenzelbrille/Nystagmus (kein Nystagmus) Kalorik (Unerregbarkeit kranke Seite) Neurostatus : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik Gehör (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest) >Perzeptionsschwerhörigkeit, AEP normal)		1. Antiemetika (Primperan) + Antivertiginosa (Betahistin) 2. Bei Misserfolg Chirurgie (Einlage Pauckendrainage, vestibul. Neurektomie, Labyrinthektomie falls Taubheit)	Häufig, Kinder selten, z.T. bds. Möglich Prognose: i.d.R. gut
Bilaterale Vestibulopathie	Gleichgewichtsstörungen, Schwankschwindel/ Betrunkenheitsgefühl, Dunkelheit verstärkt es, opt. Fixation beim Laufen schwierig, Medis, auto-immun-Probleme	Frenzelbrille/Nystagmus (kein Spontannystagmus) Kalorik (bds. Unerregbarkeit) Neurostatus : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augemotorik Gehör (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest)		Schwierig! Intensive otoneurolog. Reha	<u>Ursache</u> erfragen: oft ototox. Medis! Autoimmun
HALS					

Larynx- + Pharynx-Ca	<u>Larynx</u>: Heiserkeit, Räusperzwang, Reflexotalgie <u>Pharynx</u>: Odynophagie, Dysphagie, blutiger Speichel, Foeter ex ore, Trismus, Hörproblem (einseitiger Paukenerguss, daran danken!), LK-Schwellungen, NAB, Epistaxis, Kopf-Sz., Hirnnervenlähmung, Heiserkeit (falls Larynx mitgefallen), Sz. <u>RF</u>: Nikotin, Alk, ev. HPV + EBV	Inspektion Hals Palpation Mund + Rachen Laryngoskopie Gehör: o.B. Lymphknoten (Pharynx-Ca: 1. Zeichen oft LK-Metastasen!)	<u>Larynx</u> Laryngoskopie mit Biopsie, ev. Panendoskopie FNP v. LK US Staging: MRI/CT/PET <u>Pharynx</u> BE: EBV-Titer Panendoskopie mit Biopsie FNP v. LK US Staging: MRI/CT/PET	LARYNX Stimm lippen-Ca: RT, ev. Laser Kleine Larynx-Ca: RT/Laser (falls supraglottisch reicht oft RT nicht >Teilresektion nötig) Grosse Larynx-Ca: RT-Chemo + Neckdissection, partielle od. totale Laryngektomie (temp. Tracheo, bei totaler LE permanente Tracheo. Nötig >Stimmprothese od. eigene Ersatzstimme), PHARYNX <u>Nasopharynx</u> (Selten): PE-Ca, Lypho-EP-Ca (EBV)> RT-Chemo (Kurat. Ops i.d.R. nicht mehr möglich) <u>Oropharynx</u>: PE-C, Lyphom >Chirurgie + Neckdissection + RT-Chemo, od. nur RT-Chemo (kurativ) <u>Hypopharynx</u>: PE-Ca >"" ev. zusätzlich Larynx-Ops, selten Pharyngo-Laryngektomie (s. schwierig!) Bei LK-Metastasen: Neckdissection	
Lymphadenopathie	Akut od. chronisch, Infekt d. oberen Atemwege, Fieber, AZ oft red., Sexualkontakt, Tiere, Auslandsreise	Inspektion + Palpation Hals Lymphknoten Mund + Rachen (Rötung, Tonsillitis) Ohren Nase Ev. Internist. Status (Lunge)	<u>Akute LA</u>: keine Diagnostik >klin. Dx, allenfalls BE <u>Chron. LA</u>: BE (LK, CRP, Serologien: EBV, HIV, Toxoplasmose, Syphilis, etc.), US, ev. CT, FNP ev. Keine Biopsie!	Therapie Grunderkrankung, symptomatisch, ev. AB, falls Abszess Inzision/Drainage, Medi absetzen falls Medi-bedingte LA	<u>Akute-entzündliche LA</u>: <4 Wo., meist i.R. Infekt obere Atemwege (oft bei Tonsillitis + Pharyngitis) <u>Chronisch-entzündliche LA</u>: >4 Wo., Toxoplasmose, HIV, Tbc, Lues, Katzenkratzkrankheit <u>Arzneimittel-LA</u>: symptomlose LK
Mumps/Parotitis epidemica	Schwellung Wange, Beginn einseitig + nach ca. 2d oft bds., LK, Kauen + Kopfbeweg. Sz-haft, Fieber	Inspektion + Palpation Hals (teigig-ödemat. Schwellung Regio parotidea) Lymphknoten Mund + Rachen (Rötung, Tonsillitis) Ohren Nase Ev. Internist. Status (Lunge)		Symptomatisch: NSAID, Fiebersenker Bis 9d nach Symptomen keine Gemeinschaftseinrichtungen besuchen!	Paramyxovirus parotidis
Missbildungen am Hals	Meist indolente Schwellung lat. od. median am Hals, angeboren, oft erst symptomatisch bei Infekten <u>Laryngozele</u>: Globusgefühl, Dysphagie, Heiserkeit, Halsschwellung, Blasinstrumentenspieler, Pressen bewirkt Vorwölbung	Inspektion + Palpation Hals Lymphknoten Mund + Rachen Ev. Ohren, Nase Ev. Internist. Status (Lunge)	Keine Biopsie! US, ev. CT Bei Laryngozele: Laryngoskopie	<u>Lat. + med. Halszyste</u>: Exzision (Inzision/Drainage löst Problem nicht >Rezidive) <u>Lat. + med. Fisteln</u>: müssen verschlossen werden <u>Laryngozele</u>: Ops	Laterale Halszyste/Fistel: wird oft bei Infektion symptomatisch (schwillt an) Mediane Halszyste/Fistel: prall-elast., folgt Bew. d. Zungenbeins beim Schlucken, wird oft bei Infekten symptomatisch, muss gesamtes hyoid entfernen sonst Rezidiv Laryngozele: innere (n. sichtbar v. aussen) + äussere Form,

Schilddrüsenpathologien	Hyper- + Hypothyreose-Symptome abfragen, Systemanamnese, B-Symptome, Sz.,	Inspektion + Palpation Hals „SD, Schlucktest Lymphknoten Lyngoskopie	BE (AK, SD-Hormone, CRP), US, Szintigraphie, FNP Keine Biopsie!	Je nach Ursache	DD: Struma (Iodmangel u.a.), Autonomie/Knoten, Entzündungen/autoimmun (Hashimoto, M. Basedow, Th. de Quervain), Neoplastisch (follikuläres + papilläres Adenom od. Karzinom, Anaplast. od. medull. Ca)	
Madelung Fetthals	Männer zw. 40-50 J., oft bei alk. Hepatopathie od. DM,	Inspektion + Palpation Hals Lymphknoten Mund + Rachen Ev. Ohren, Nase Ev. Internist. Status (Lunge)	Keine Biopsie! FNP Therapie Chirurgische Resektion Gutartig, häufig Rezidive!	Weitere gutartige Tumoren Lipom (DD Liposarkom), Neurinom/Schwannom (ev. Nervendysfunktion), Glomus-Caroticum-Tumor (BD-Abfälle bei Halsbewegungen, pulsierender Tumor, vor Resektion Bildgebung, ev. Angio/Embolisation), Hämangiom (oft angeboren od. seit klein, rötlich-weich, oft Spontanheilung, sonst B-Blocker/Embolisation/Laser/Resektion) >meist symptomlose Schwellung >Resektion		
Metastasen	meist >60, meist solitäre indolente harte LK-Schwellung, oft bei Raucher + Alk, Primärtumor/PE-Ca meist im HNO-Bereich >suchen, B-Symptome	Inspektion + Palpation Hals Lymphknoten Mund + Rachen Ohren Nase Ev. Internist. Status (Lunge)	FNP, PET-CT (Staging, suche Primärtumor!), ev. Panendoskopie mit Biopsien Keine Biopsie d. Metastase/LK!	Je nach Stadium + Tumor	DD: Lymphom (solitärer LK od. generalisiert, RT-Chemo reicht, FNP + bei Verdacht Exzision ganzer LK um Typisierung zu machen)	
Speicheldrüsen	Sialolithiasis: Postbrandiale Schwellung + danach Besserung, Kollik, ev. Eiter, M>F, in 80% Submandibularis Sialadenitis: Sz., Schwellung, meist Submandibularis Sialadenose: Schwellung, Xerostomie, Xerophthalmie, keine E., oft metabolische Probleme (DM, SD, Unterernährung, Nierenproblem) od. Medis Sjögren-Sy: Schwellung Parotis, Xerostomie, Sicca-Sy/Xerophthalmie >Keratokonjunktivis Pleomorphes Adenom: Schwellung/RF, meist indolent, selten Fazialisparese Warthin Tumor/Zystadenolymphom: Schwellung/RF, meist indolent, selten Fazialisparese Zysten Mukoepidermoid-Ca, Adenoid-zystisches-Ca, PE-Ca: *Pleomorphes Adenom: i.d.R. lat. Parotidektomie (Fazialisserhaltung, keine Enukleation weil Pseudopodien >Rezidive!)			Sialolithiasis: US, Rx (Stein), CT, Sialendoskopie Sialadenitis: US (Ausschluss Sialolithiasis), BE (Serologien: Mumps, CMV, etc.), ev. Sialendoskopie Sialadenose: keine Biopsie, ev. S-Endoskopie, US Sjögren-Sy: Sialometrie, Schirmertest, BE (Rheumaf.), Unterlippen-Biopsie Tumoren: US, FNP (keine Biopsie!), CT/MRI		Therapie Sialolithiasis: Sialogoga (Chätschi, Zitronie >Speichelprod. ⌈), Sialendoskopie, Transorale Gangschlitzung, Lithotripsie (Zertrümmerung, prakt. nie), Submandibulärektomie (falls Rezidive) Tumoren*: falls in FNP maligner Prozess >Chirurgie >itraop. Schnellschnitt >falls benigne lat. PE, falls maligne totale PE + Neckdissection, ev. postop-RT